ALTAMEDICA
ARTEMISIA

Servizio di Genetica Medica
ARTEMISIA SPA - P. IVA 00929551000
00198 ROMA - Viale Liegi, 45
Tel 06 85 05 804-5-6 | Centralino 06 85 05 (r.a.)
www.altamedica.it - segreteria.geneticamedica@altamedica.it
Resp. Dott. Alvaro Mesoraca
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

Il tuo profilo genetico ha evidenziato

UNA PREDISPOSIZIONE GENETICA AD UNA BASSE SENSIBILITÀ ALLA CAFFEINA (METABOLIZZATORE VELOCE)

I tuoi geni hanno dimostrato una **bassa sensibilità alla caffeina**.
Ovvero il tuo organismo impiega meno tempo per metabolizzare la caffeina e questo potrebbe avere effetti negativi sulla tua salute.

Per molti anni la letteratura ha cercato di definire il rischio o il vantaggio di tale assunzione nei metabolizzatori veloci della caffeina.

Circa un decennio fa, il Dr. Ahmed El- Sohemy, professore nel dipartimento di scienze nutrizionali dell'Università di Toronto, notò come la caffeina avesse un effetto diverso sul genoma delle persone. In particolare è stato dimostrato, dal Dr. El- Sohemy e dai Suoi colleghi, che i metabolizzatori veloci di caffeina, in seguito all'assunzione da 1 a 3 tazze di caffè al giorno, presentano una riduzione del rischio di ipertensione e di infarti.

Nonostante i benefici, è consigliato non superare la dose giornaliera consigliata di caffeina, in quanto, anche essendo un metabolizzatore rapido, potresti incorrere in alcune complicanze come le patologie cardiovascolari.

Consigli alimentari in base al tuo profilo genetico:

È quindi importante limitare l'assunzione di caffé a 3 tazzine al giorno

Attenzione: la caffeina non si trova solo nel caffè, è importante limitare anche il consumo di tè, cioccolato, coca cola, pepsi, e altre bevande contenenti caffeina.

Sono consigliati caffè preparati con la moka o in cialde di carta, al contrario delle capsule in alluminio.

Metodi alternativi per zuccherare il caffè: eritritolo, latte di mandorla, latte di cocco, latte di soia

Bibliografia

Cornelis MC, El-Sohemy A, Kabagambe EK, Campos H. Coffee, *CYP1A2 genotype, and risk of myocardial infarction.* JAMA. 2006 Mar 8;295(10):1135-41. doi: 10.1001/jama.295.10.1135. PMID: 16522833.